リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月13日（火）

第33号　朝刊

■ 脳卒中・ロボット訓練

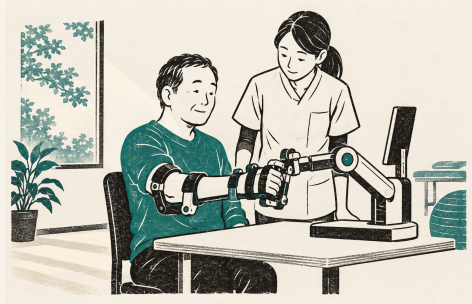
脳卒中後のロボット訓練、上肢とADLに効果もバランスは差なし　36RCT

訓練量と成績の間に有意な関係は見つからず（システマティックレビュー）

脳卒中後のロボット支援訓練（RAT）について、PubMedなど4つのデータベースを2025年10月まで検索し、成人を対象にRATまたはRATと通常リハの併用を比べたRCT 36件・1,941人を統合したシステマティックレビューが、Medicineに出ました。

通常のリハビリと比べて、上肢のFugl-Meyer（FMA-UE）は平均差2.89点（95%CI 1.49～4.28）、ADLは標準化平均差0.28（0.13～0.43）で上回りました。バランスは平均差1.27点（-0.92～3.47）で有意差がありません。エビデンスの確実性は、FMA-UEとADLが中等度、Berg Balance Scaleが低いと評価されています。

訓練量5項目とアウトカムの間には、直線的にも非直線的にも有意な関係が見つかりませんでした。ただし実際の訓練量の報告が不十分で、層ごとの研究数も少なく、著者も慎重な解釈を求めています。「量を増やせば伸びる」とも「量は関係ない」とも言えず、上肢とADLの底上げ手段として訓練量の根拠はまだ弱く、上肢とADLの補助として位置づけるのが妥当です。



出典 Medicine ↗

数字で見る

1,941人
解析した脳卒中の成人（36件のRCT）

2.89点
上肢Fugl-Meyerの平均差（95%CI 1.49～4.28）

1.27点
Berg Balance Scaleの平均差（CI -0.92～3.47）

■ 脳卒中・痛み

脳卒中歴のある高齢者は活動を妨げる痛みが多い　米12,797人

米国の高齢者調査NHATS（2011～2024年）の65歳以上の地域在住者12,797人を解析した横断研究（Physiother Theory Pract）。脳卒中の既往があったのは2,235人（15.71%）でした。



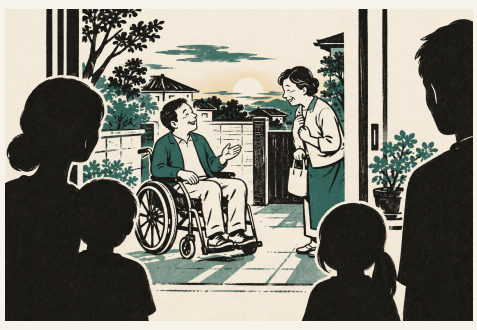
つらい痛みは60.77%対54.66%、活動を制限する痛みは62.83%対52.00%と、既往のある群で多い結果です。多くの要因を調整しても、オッズ比は1.30（95%CI 1.02～1.66）と1.20（1.04～1.38）で残りました。脳卒中歴は自己申告で、痛みの部位や原因は不明、因果は言えません。

出典 Physiother Theory Pract ↗

■ 脊髄損傷・社会参加

脊髄損傷後の社会的統合の低下、死亡リスク上昇と関連　16,783人

米国のSCI Model Systemsデータを使い、外傷性脊髄損傷の成人16,783人の社会的統合（CHART）と死亡の関係を縦断的に調べた研究（Arch Phys Med Rehabil）です。122,626人年で2,965人が亡くなりました。



CHARTが10点低いごとの死亡ハザード比は1.09（95%CI 1.07～1.10）で、個人内で点数が下がった場合も1.077でした。死因不明が23.2%あり、因果は言えません。退院後の参加の低下を見守る材料になります。

出典 Arch Phys Med Rehabil ↗

短信

〈脳卒中〉 **慢性期のtaVNS併用訓練、FMA-UEが上回る**
40人RCT、4週。FMA-UE差3.95点（CI 0.21～7.69）で下限は臨床的最小差に届かず。 出典 NeuroRehabilitation ↗

〈脳卒中〉 **血流制限トレーニング、効果は一貫せず**
ナラティブレビュー。脳卒中の臨床研究は8件のみで、通常運動に常に勝るとは言えない。 出典 Brain Behav ↗

〈顔面麻痺〉 **脳卒中後の顔面麻痺にキネシオテープ**
121人RCT、4週。張力ありが偽テープ・対照を顔面機能指標で上回り、食物残渣も少ない。 出典 Medicine ↗

〈呼吸〉 **慢性片麻痺の胸郭テーピングで肺機能改善**
30人RCT、4週。FVC・FEV1・MIP・FIMで偽テープを上回る。小規模で慢性期のみ。 出典 Top Stroke Rehabil ↗

〈ST〉 **失名詞に頭皮鍼＋言語療法、呼称が上回る**
85人RCT、4週。WAB呼称得点でP=0.009。鍼の盲検化は抄録に記載なし。 出典 Chin Med ↗

〈心理〉 **脳卒中後うつに角調音楽療法を併用**
91人RCT、6週。HAMD-24とBarthel Indexが通常ケアより改善。盲検化の記載なし。 出典 Int J Psychiatry Med ↗

〈家族支援〉 **STN-DBS後の介護負担、年数とともに増加**
パーキンソン病88組の横断研究。嚥下障害と認知症が負担と関連し、運動重症度は無関連。 出典 Mov Disord Clin Pract ↗

〈認知〉 **認知運動介入後のMMSE、8週で22.3→26.3**
中国200人の観察研究。予測モデルのAUCは0.758で、対照群の位置づけが曖昧。 出典 JCPSP ↗

〈整形〉 **手関節鏡後の段階的リハ、3・6か月で良好**
単施設の後ろ向き94人。合併症の差は有意でない（6.4%対15.3%）。 出典 JoVE ↗

〈他職種〉 **歯科医のTMD物理療法、十分な知識は32.9%**
イエメン426人の調査。研修参加で知識・実践が上がる関連（AOR 3.11）。 出典 Clin Cosmet Investig Dent ↗